

Kvaliteetne sotsiaalteenus on isikukeskne



Keiu Talve

sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse juhataja, Astangu Kutsererehabilitatsiooni Keskus

Kvaliteedisüsteemi rakendamist alustatakse tavaliselt eneseanalüüsist. See on protsess, mille käigus hinnatakse olemasolevate süsteemide vastavust standardi nõuetele. Heaolu arengukavagi saab käsitleda kui sotsiaalvaldkonna peegelpilti: praegusi probleeme võrreldakse oodatava ideaaliga aastal 2023. Mõistet *kvaliteet/kvaliteetne* on arengukava 52 leheküljel kasutatud 81 korral 23 erinevas kontekstis alates tööelu kvaliteedist, elukvaliteedist, kvaliteetsete kaitsemehhanismide ja mõju hindamise kvaliteedini. Täites arengukava eesmärke, on sotsiaalsektor aastal 2023 tunduvalt kvaliteetsem.

Kuid astume sammukese tagasi. Lihtne on seada eesmärk, et tahame kvaliteetsemaid teenuseid. Kas meile on aga selge, mida päriselt tähendab kvaliteetne sotsiaalteenus, kvaliteetne kõrvalabi, kvaliteetne avalik teenus? Arengukavas on väga mitme teema puhul räägitud ligipääsust teenustele, eri institutsioonide koostoisest, vajadustest lähtuva (vajadustele vastava) teenuse korraldusest, inimeste kaasamisest ja nende võrdsest kohtlemisest, kompetentside arendamisest ning isikukesksusest. Kõik need omadused on osa kvaliteetsest sotsiaalteenusest, kuid mõisted on tarvis lahti mõtestada, et aru saada, mille poole järgneva seitsme aasta jooksul püüeldakse.

Millest räägime, kui räägime kvaliteedist

Astangu Kutsererehabilitatsiooni Keskuse

sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse üheks tegevuseks 2016. aastal on välja töötada sotsiaalteenuste üldine kvaliteedijuhis ja spetsiifilised kvaliteedijuhised, mis aitaksid tõsta teenuste kvaliteeti. Koostatav juhise peaks vastama Euroopa Liidus sotsiaalteenustele esitatavatele nõuetele ning olema arusaadav igale sotsiaalteenuse pakkujale. Kvaliteedijuhise koostamine on üks esimesi suuremaid samme sotsiaalteenuste kvaliteedist ühtse arusaama kujundamisel: see on kokkulepe, mis ütleb, et teame, millest räägime, kui räägime teenuste kvaliteedist.

Seda on vaja peamiselt selleks, et liikuda kvaliteedist rääkides klientide arvu, klienditöö tundide ja ruumide ruutmeetrite lugemise ning „linnukeste” tegemise juurest teenuse sisu juurde. Kes on meie klient? Mida ta vajab? Mida saame tema heaks teha? Kuidas saame talle lisandväärtust pakkuda tema enda soovide ja vajadustest lähtudes? Kas kohtleme inimest nii, nagu soovime, et meid koheldaks, kui meile pakutaks sama teenust? Kas klient kaob süsteemi rägastikku ja piirangutesse või proovitakse leida võimalusi ja lahendusi? Kas anname endast parima, et saavutada teenuse eesmärk või toetame inimest tema eesmärkide saavutamisel? Kas inimese elus tänu teenusele reaalselt midagi muutub?

Isikukesksuse kui ühe kvaliteetse ja tänapäevase sotsiaalteenuse tunnuse puhul tuleb just neid küsimusi esitada. Peamine nii arengukavas kui ka klienditöös pole otsida

probleemi, millega tegelema hakata, vaid inimeste vajadusi, mida rahuldada. Ja see ei olegi nii lihtne.

EQual mudel

Teist aastat järjest katsetame Eestis teenuste mõju ja tulemuslikkuse metoodikat, mis põhineb kliendi elukvaliteedi hindamisel. EQual mudel on pärit Norrast ja sai kindla vormi pärast aastatel 2006–2009 ellu viidud projekti „*Nytt fokus – ny job*” („Uus fookus – uus töö”), mille käigus tuvastati, et tavapärase lähenemise korral sotsiaalteenustele olid mõned piirangud:

1. Individuaalsete tulemuste mõõtmiseks ei olnud häid töövahendeid. Olid vaid kindlate indikaatoritega standardiseeritud instrumendid, millega mõõta kvantitatiivseid tulemusi.
2. Puudusid igasugused töövahendid, millega mõõta, kui palju teenus kliendi elukvaliteeti mõjutab.
3. Olemasolevate lähenemised ei võimaldanud kliente piisavalt kaasata ega tekitanud neis vajadust ise oma elu üle otsustada, kuigi teenuste edukus sõltub paljuski just klientide kaasatuse ning osaluse määrast.

„EQual mudelis ei ole iseenesest midagi uutset. Selles vaadeldakse inimest kui tervikut, keskendutakse inimese elukvaliteedi tõstmisele, töötatakse individuaalse plaani alusel ning hinnatakse eesmärkide saavutamise tulemuslikkust. Erinevus seisneb selles, kuidas seda kõike tehakse,” ütleb metoodika autor Geir Moen.

Inimese vaatlemine tervikuna seisneb selles, et soove ja vajadusi ei hinnata vaid ühest kindlast teenusest lähtudes, vaid arvestatakse inimese elukvaliteedi/heaolu kogu spektrit: füüsiline ja vaimne heaolu, eneseteadlikkus ja õigused, sotsiaalne kaasatus, emotsionaalne heaolu ja suhted, isiklik areng ning materiaalne

heaolu jne. Inimene ise ütleb, mis on tema peamine eesmärk/unistus/soov elus (NB! mitte teenusel, vaid elus) ning sellest lähtudes hakkavad selguma ka tema täpsemad eesmärgid ning tegevused, et neid ellu viia.

Oluline antud metoodika juures on see, et töö tegemine, tööle saamine või õppima asumine ei ole kunagi eesmärk omaette, vaid vahend mõne muu eesmärgi saavutamiseks. Näiteks võib olla ühe töötu keskealise inimese unistuseks, et ta saaks kordki elus oma pere välismaale reisile viia. Siin ongi üheks võimalikuks vahendiks tööle saamine, tööl käimine, raha kogumine ning seejärel ta saabki mõne aja pärast pere reisile viia. Teiseks näiteks võib tuua nooruki, kel on vaimupuue, diabeet, suur ülekaal ning kes ei ole motiveeritud rohtusid võtma ega tööl käima, kuid väga soovib iseseisvalt elama asuda. Seega on tema eesmärk iseseisev elu, mis tähendab perest eraldi elamispinda ja mille puhul on vahendiks tööl käimine, et teenida elatist ja suuta maksta elukoha eest. Samuti on vahendiks rohtude võtmine ning kehaline aktiivsus, et olla tööl käimiseks terve.

Nende näidete puhul on inimese jaoks väga selge, MIKS üht või teist tegevust on vaja või mida saavutada. Selle tõttu langeb vastutus kogu protsessi eest rohkem inimesele ja ka motivatsioon eesmarke saavutada on suurem, kuna need on inimese enda, mitte teenuse eesmärgid. Samuti saab selgeks, et individuaalses plaanis võivad eesmärgid olla palju laiemad, kui antud teenuse piirid seda hetkel võimaldavad.

Kui räägime terviklikust lähenemisest, teenuseülesest koostööst, kogukonnapõhisusest ja inimese elukvaliteedi tõstmisest, siis inimese eesmärgid elus jäävad samaks vaatamata sellele, kas ta üht või teist teenust saab või mitte. Inimese eesmärkide täitmisel saab teha koostööd erinevate sotsiaalsete ja muude osapooltega nii tema kodukohas kui

ka sellest väljaspool. Seega võiks inimene eQual mudeli põhjal koostatud individuaalse plaani eesmärkide poole pööelda ka siis, kui teenus saab läbi, sest see on TEMA, mitte teenusepakkuja plaan, mis lõppeb samal hetkel, kui lõppeb teenuse rahastus.

Tulemuste mõõtmine

Järgmiseks metoodika erinevuseks on see, et antud lähenemine võimaldab mõõta inimese elukvaliteedi tõusu. Metoodika keskendub eraldi eesmärgistamise ja tulemuslikkuse mõõtmisele. Kuidas seada eesmärke nii, et nende saavutamist oleks hiljem võimalik mõõta? Kui eesmärgiks on iseseisvuse suurenemine, siis mille alusel teatud aja möödudes võime öelda, kas inimene on varasemast iseseisvam või mitte? Millist muutust me teenuse osutamisega inimeses esile kutsume?

Selleks et tulemuslikkuse mõõtmise juurde jõuda, on tarvis välja tuua veel üks väga oluline aspekt. Nimelt lähtub eQual metoodika sellest, et iga inimese puhul on elukvaliteedi hinnang subjektiivne ning tulemuslikkust näitavad erinevad subjektiivsed tulemuslikkuse indikaatorid koos.

Ei ole võimalik kehtestada üldisi indikaatoreid, et neid siis kõigi klientide puhul teenuste tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutada. Ka eesmärkide ja tegevuste arv on iga inimese puhul erinev: mõni inimene ei sea füüsilisele heolule ühtegi eesmärki, teisel on kõik eesmärgid vaid sellega seotud. Ühel on vaja leida heoluks partner, teine soovib vaid rahu ja vaikust ning et kolm korda päevas oleks toit laual.

Elukvaliteedi tõusu saabki mõõta, koondades iga eesmärgi olulisuse hinnangu inimesele ning eesmärgi täitumise seisule hindamise hetkel ja pärast tegevuste elluviimist. Väljatöötatud valemi alusel saamegi teada, kas elukvaliteet pärast tegevuste elluviimist on tõusnud, säilinud või kahanenud.

Eesmärgi sõnastamine

Väga oluline tulemuslikkuse mõõtmise juures on eesmärgistamise sõnastusel. Metoodika autor Geir Moen kasutab koolitustel selle selgitamiseks väga lihtsat näidet. Kuidas mõõta eesmärki „tahan saada rikkaks”? Millal olen piisavalt rikas ning tunnen, et nüüd on eesmärk saavutatud? Ebaselge on ka see, mis ajaks ma rikkaks saada tahan. Kui aga sõnastada eesmärk nii: tahan, et mul oleks 5000 eurot vaba raha selleks ajaks, kui lähen pensionile, et saaksin tegeleda oma hobidega. Selge on tähtaeg, summa ja põhjus, miks antud eesmärk on oluline. Siit saab väga lihtsalt välja arvutada, mitu aastat on mul jäänud pensionile minekuni ja seega saan ka teada, kui palju peaksin igas kuus ja aastas säästma, et seda summat kokku saada.

Samamoodi saab seada eesmarke näiteks tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavas. Vaatleme klienti, kes kasutab liikumiseks ratastooli. Suunamiskirjas on eesmärgiks töövõime säilitamine tervises seisundi ja töökeskkonna parendamise (kohandamise) kaudu. Teenusest lähtudes väga asjakohane eesmärk, kuid see ei lähtu kindlasti inimesest. Inimene, kes võtab vastutuse oma elu ja heaolu eest ning käsitab oma elu tervikuna, ütleks pigem „tahan olla terve ja elada valuvaba elu, et saaksin käia tööl ning elada võimalikult iseseisvalt”. Sellele järgneb rida kitsamaid eesmarke ning tegevusi, kuidas seda eesmärki saavutada ja selle tulemuslikkust mõõta.

Selleks et isikukesksus ei kaoks ära vormidesse ning teenuste piirangutesse, pole vaja süüdistada teenuste korraldajaid või vormide koostajaid. Teenuse pakkujatena saame tühjadesse vormilahtritesse kirjutada just seda, mis on meie ja meie klientide kui inimeste jaoks oluline. Isikukesksus seisneb peamiselt vaatenurgas, oskuses näha laiemalt ning soovis anda inimesele võimalus viia ellu muutusi, et elada paremat elu.